31. L'APPARATO GENITALE FEMMINILE

DURATA : 06:15 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità lo sviluppo dell'apparato genitale femminile, iniziando dalla formazione dei dotti di Wolff e di Müller, e il loro impatto sulla struttura riproduttiva. L'accento è posto sulla relazione uro-genitale che differisce tra uomo e donna, mettendo in luce la creazione dell'utero e delle tube. Approfondiamo anche il ruolo dei legamenti larghi e ovarici, così come l'importanza della salute renale nella regolazione ormonale e nella fertilità. Il video affronta la continuità fasciale nel bacino e come anomalie come i fibromi possano influenzare l'intera dinamica corporea, fornendo informazioni cruciali per i praticanti in osteopatia e nello sviluppo embrionale.

L'APPARATO GENITALE FEMMINILE

1. DOTTO MESONEFRICO (CANALE DI WOLFF) E PARAMESONEFRICO (CANALE DI MÜLLER)

Il **canale di Wolff**, chiamato anche **dotto mesonefrico**, è il primo canale che appare nell'embrione.

Nell'uomo, questo canale scende e viene integrato tra i testicoli per formare il **dotto eiaculatore**. Al contrario, il canale di Müller rimane come vestigio e contribuisce alla formazione del cuore della prostata.

Nella donna, la situazione è invertita:

- Il canale di Wolff si differenzia in **organi di Gardner**, che sono dei vestigi.
- Il canale di Müller, per fusione, diventa l'**utero** e le **tube**.

SVILUPPO URO-GENITALE

La relazione **uro-genitale** è fondamentale. Nell'uomo, il dotto epididimario, il dotto deferente e il dotto eiaculatore si formano a partire da questa relazione.

Nella donna, questo sviluppo non avviene allo stesso modo. Il canale di Müller si riunisce verso la linea mediana per formare l'utero.

Gli organi di Gardner rappresentano i vestigi del canale di Wolff nella donna. Il dotto eiaculatore è orientato verso la base, e più ci si allontana, più formerà l'utero. Meno ci si allontana, più il vestigio sarà il **triculo prostatico**.

2. IL LEGAMENTO LARGO E I LEGAMENTI OVARICI

Nell'uomo e nella donna, il **peritoneo parietale posteriore** si concentra per formare il **legamento largo**, così come i piccoli legamenti ovarici e i legamenti rotondi.

È lo stesso tessuto, ma con concentrazioni diverse. Questo peritoneo parietale posteriore formerà l'utero nella donna.

Nell'uomo, questo movimento non esiste, e rimane solo una concentrazione di peritoneo.

3. IL RENE E IL SURRENE

Il rene è situato al di sotto del **surrene**, separati da una capsula. Ciò significa che una **ptosi renale** non comporta una ptosi surrenalica.

Sono separati da una fascia chiamata la **capsula di Glisson**. Il rene necessita di uno spazio adiposo.

Nelle donne molto magre, una ptosi del rene può causare irregolarità mestruali e una ridotta fertilità. **Redinamizzare un rene**, significa anche redinamizzare la sua fertilità.

SVILUPPO EMBRIONALE DEL RENE

Inizialmente, in un piccolo embrione, i reni sono enormi, così come il fegato. Questo ricorda lo sviluppo del cervello, che è molto sviluppato rispetto al tronco all'inizio.

Queste proporzioni evolvono durante lo sviluppo. Il fegato gioca un ruolo importante nello sviluppo delle surrenali.

È la prima volta che si osserva una **differenziazione strutturale** tra l'uomo e la donna, legata allo sviluppo più importante delle ghiandole che creano il **tubercolo di Müller**.

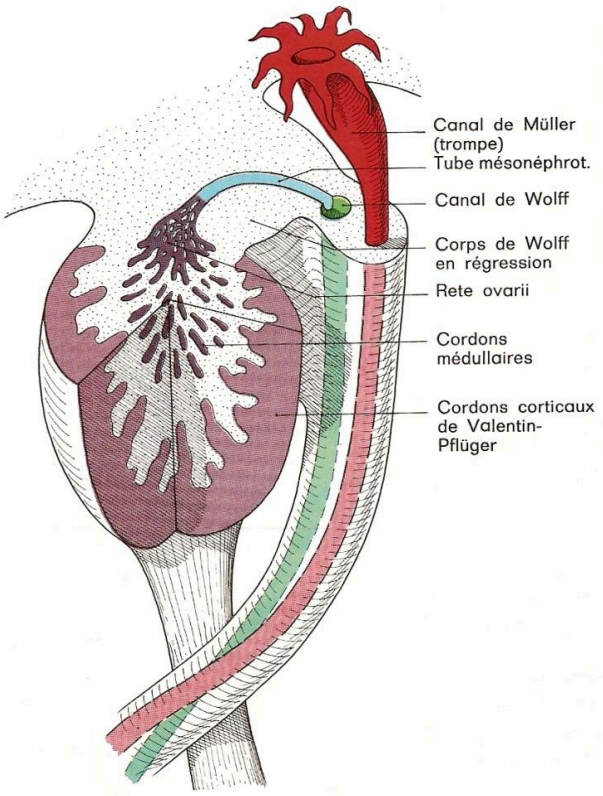


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Differenziazione ovarica

4. SVILUPPO DEL SISTEMA DI MÜLLER (5A SETTIMANA)

Alla quinta settimana, il sistema sotto il lato inizia a svilupparsi, ridando tutta la potenza al rene.

Il cervello influenza l'instaurarsi del cuore, che a sua volta instaura la **diaframmatizzazione**, il fegato, le surrenali, le gonadi e la cresta.

Il canale di Müller si sviluppa molto più fortemente nella donna per creare un canale puro, che si unisce per formare l'utero.

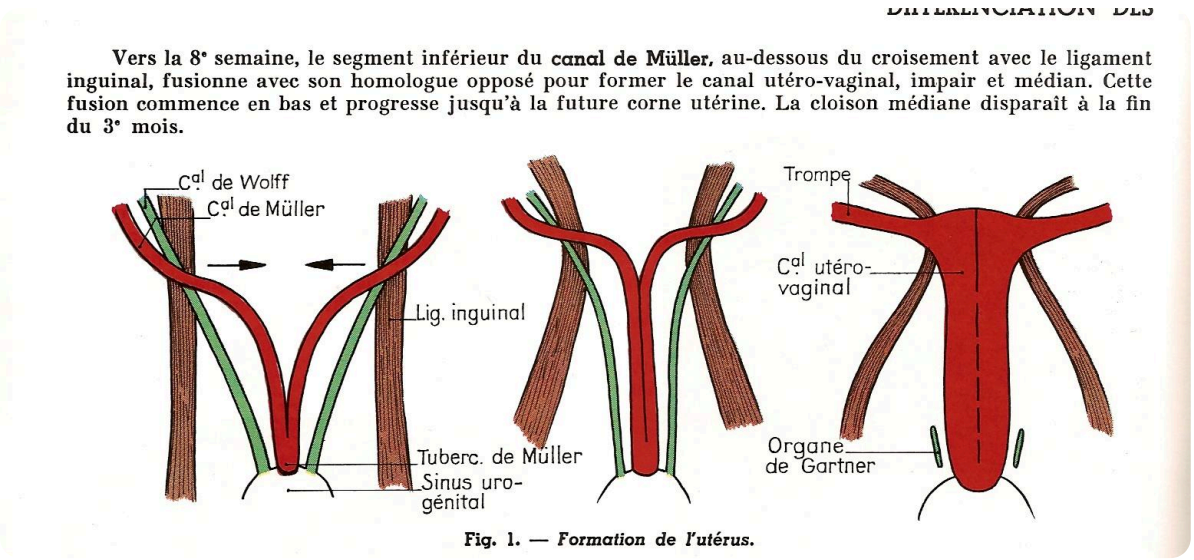


FIG. — Formazione utero embrionale

Nell'uomo, lo sviluppo è meno pronunciato, e ciò che rimane in basso del canale di Müller costituisce il cuore della prostata.

DISCESA TESTICOLARE

La **discesa testicolare** è dovuta alla velocità di crescita differenziata a livello del **gubernaculum**, che rallenta e tira tutto il sistema.

Questa continuità fasciale tra l'utero e tutta la parte della fascia, della pelle e del piccolo bacino è essenziale.

5. CONTINUITÀ FASCIALE E INFLUENZA DELLE STRUTTURE

Si osservano bene l'utero, i legamenti, le ovaie e la **cavità peritoneale**.

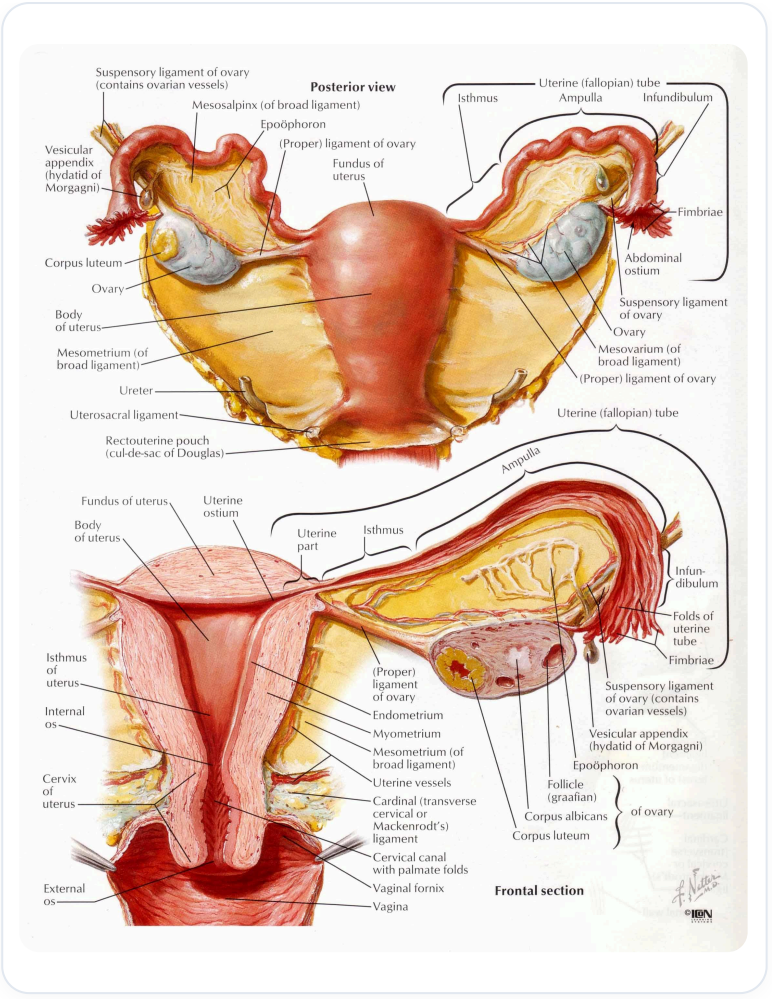


FIG. — Apparato riproduttivo femminile

Sollevando l'utero con delle pinze, si constata che tutto si muove.

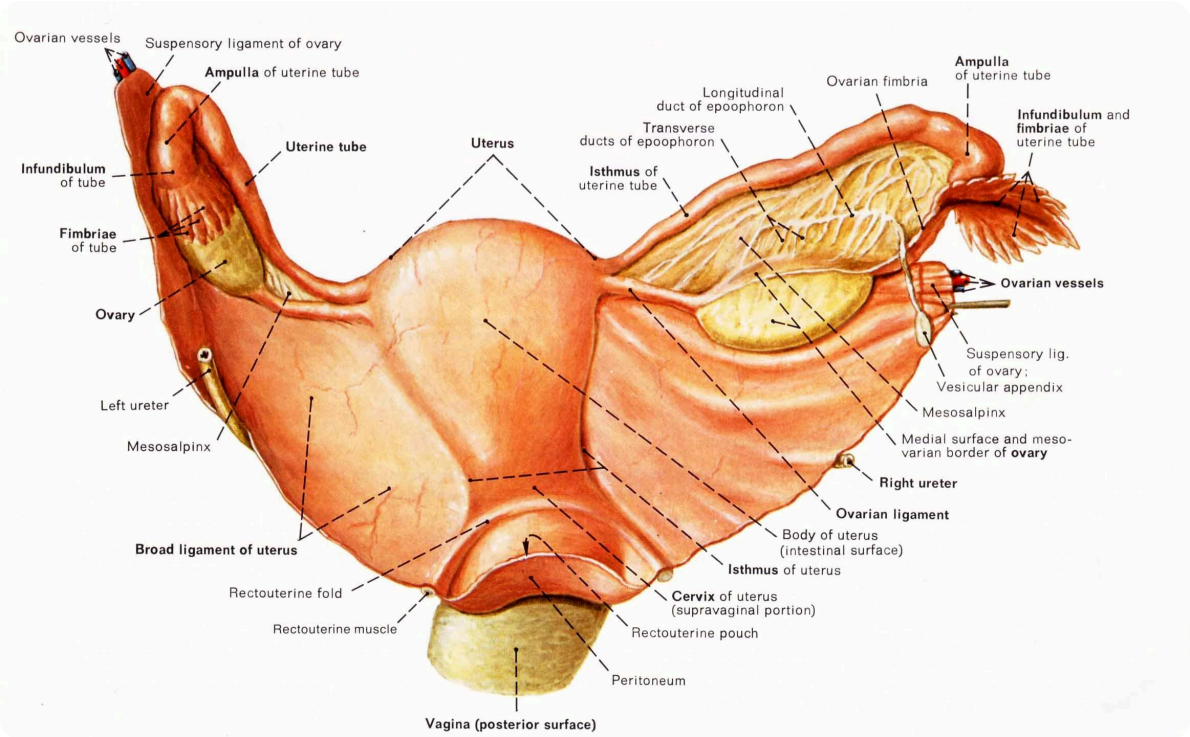


FIG. — Apparato riproduttivo femminile

L'impatto di un **fibroma** o di una **cisti** è significativo. La continuità con i legamenti è primordiale.

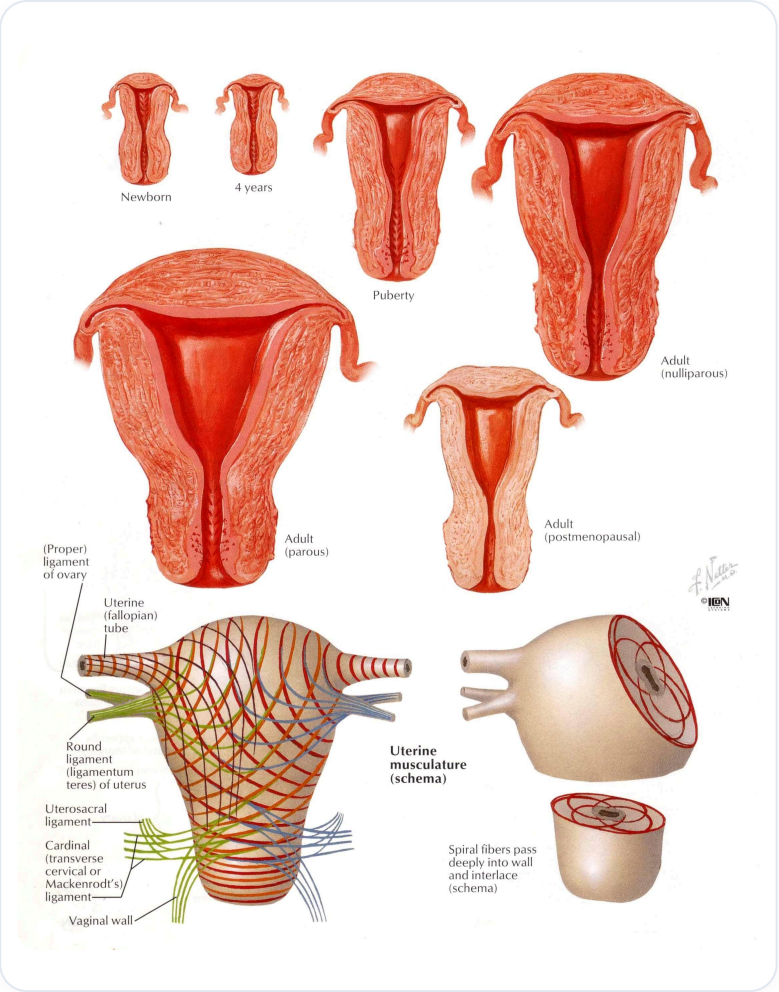


FIG. — Utero e muscolatura

Quando si tira più forte, si può vedere come tutto il sistema reagisce, inclusi i legamenti rotondi.

Il peritoneo è un tessuto molto intelligente. L'influenza di un fibroma, per esempio, può modificare tutto il sistema a valle tramite una semplice trazione.

Un grosso fibroma può causare una cascata di conseguenze in tutto il sistema.

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1 et 2).

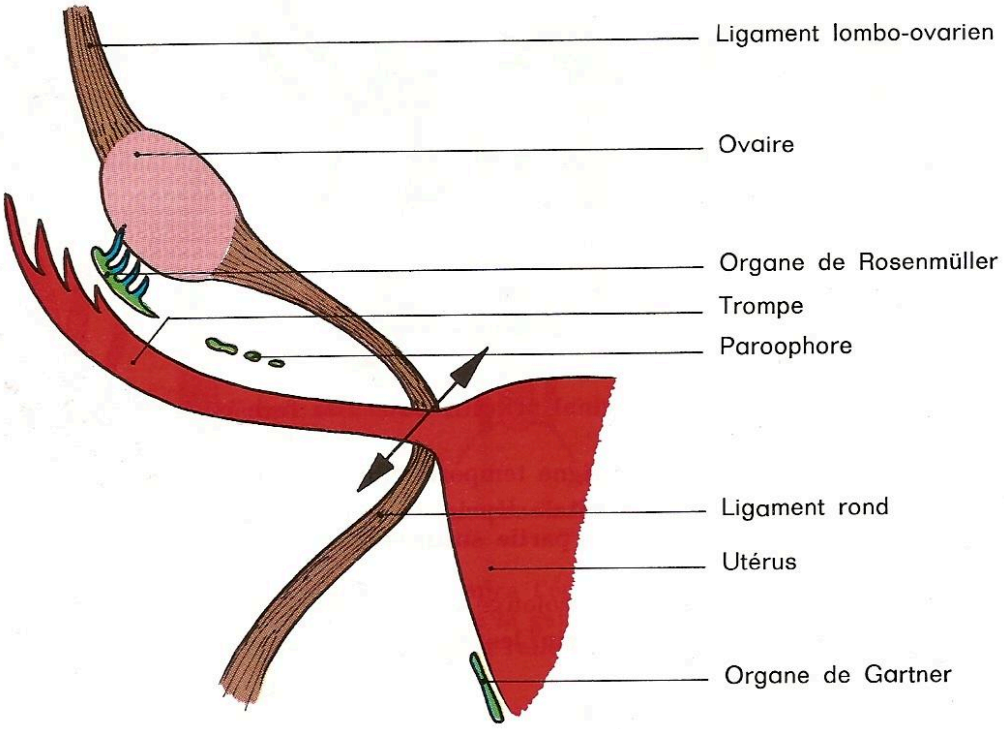
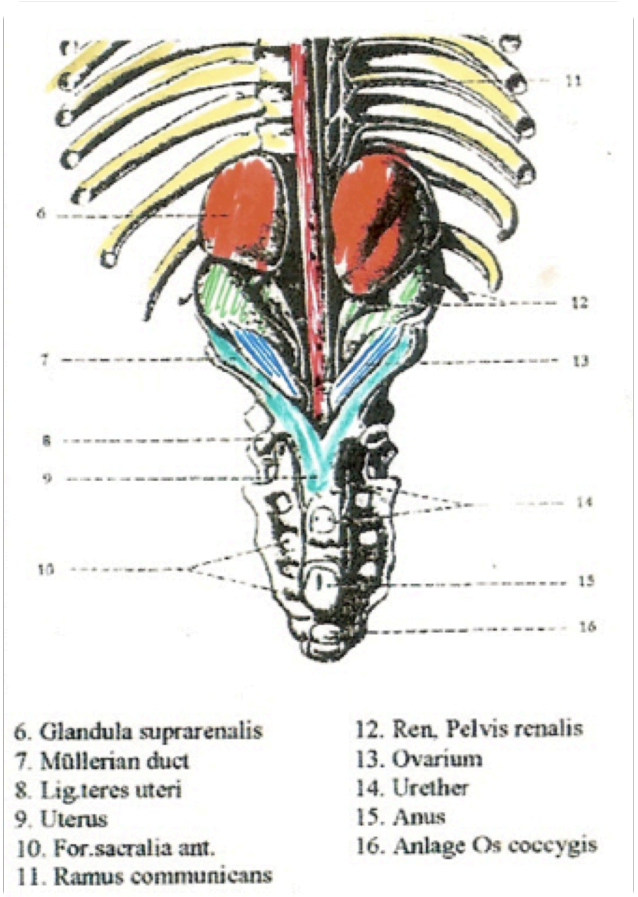


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Organi genitali femminili



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Apparato genitale fetale

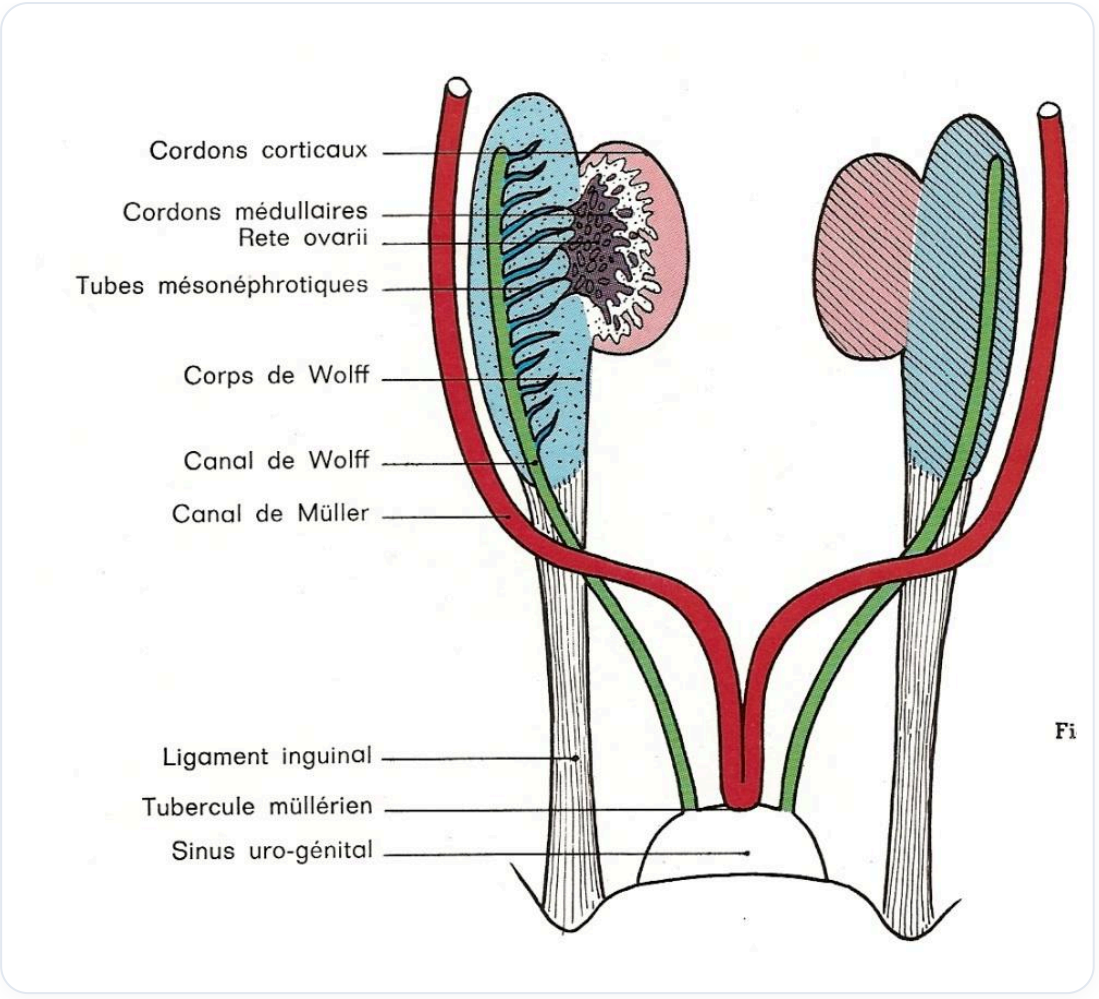


FIG. — Apparato genitale indifferenziato